



## Otonomi Pasien atas Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian: Rekonstruksi Pengaturan Post-Mortem Privacy melalui Teknologi Blockchain

Radhika Mahar Dhini<sup>1</sup>, Frestiany Regina Putri<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta

<sup>2)</sup> Politeknik Indonusa Surakarta

### Article Info

Accepted : XX/XX/XXXX

Approved : XX/XX/XXXX

### Keywords:

Rekam Medis Elektronik;  
Otonomi Pasien; Post-Mortem  
Privacy; Teknologi Blockchain;  
Perlindungan Data Kesehatan.

### Abstract

Perkembangan layanan kesehatan digital telah mentransformasi Rekam Medis Elektronik (RME) menjadi data kesehatan bernilai tinggi yang mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif. Namun, hukum Indonesia belum menyediakan mekanisme yang jelas mengenai akses terhadap RME setelah pasien meninggal dunia, khususnya terkait kewenangan dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh akses serta keberlanjutan pengakuan terhadap kehendak pasien yang telah dinyatakan semasa hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur akses terhadap RME pasca-kematian, mengkaji relevansi prinsip otonomi pasien dan konsep post-mortem privacy, serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis teknologi blockchain dalam tata kelola RME. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis, tetapi belum secara memadai mengakomodasi otonomi pasien dalam menentukan akses terhadap data kesehatan setelah kematian. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pengakuan terhadap electronic advance directives sebagai mekanisme untuk menyatakan preferensi pasien mengenai akses terhadap RME setelah meninggal dunia. Teknologi blockchain ditawarkan sebagai instrumen pendukung untuk menjamin integritas data, autentikasi, keterlacakan (auditability), dan akuntabilitas melalui mekanisme pengelolaan persetujuan yang aman. Model ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pasien, kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, serta perlindungan post-mortem privacy dalam sistem kesehatan digital Indonesia

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Radhika Mahar Dhini

Email: [radhikamahardhini@gmail.com](mailto:radhikamahardhini@gmail.com)

## I. INTRODUCTION

Kematian seseorang tidak menghapus keberadaan Rekam Medis Elektronik yang memuat data kesehatan bersifat sangat sensitif. Namun, hukum Indonesia belum memberikan jawaban yang tegas mengenai siapa yang berwenang menentukan akses terhadap data tersebut setelah pasien meninggal dunia dan sejauh mana kehendak pasien semasa hidup tetap harus dihormati. Dalam era transformasi digital kesehatan, RME tidak lagi diposisikan sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai kumpulan data kesehatan yang bernilai strategis bagi pelayanan medis, pembiayaan kesehatan, penelitian, hingga pengembangan teknologi kesehatan berbasis kecerdasan buatan (*artificial*

*intelligence*) (Mukharram et al., 2024). Semakin luasnya pemanfaatan data kesehatan tersebut diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang mampu menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Persoalannya, ketika pasien telah meninggal dunia, muncul pertanyaan mendasar yang belum memperoleh jawaban tegas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu siapa yang berhak menentukan akses terhadap Rekam Medis Elektronik dan apakah kehendak pasien semasa hidup tetap harus dihormati setelah kematiannya.

Sebagai negara yang tengah mendorong digitalisasi layanan kesehatan melalui implementasi Rekam Medis Elektronik dan integrasi platform SATUSEHAT, Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum untuk melindungi data kesehatan pasien, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pasal 32 ayat (1) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan meskipun pasien telah meninggal dunia (Tiorentap, 2020). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah melindungi kerahasiaan Rekam Medis Elektronik setelah kematian pasien. Akan tetapi, perlindungan kerahasiaan tidak otomatis berarti perlindungan terhadap otonomi pasien. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan pasien menentukan semasa hidup siapa yang berhak atau tidak berhak mengakses Rekam Medis Elektroniknya setelah meninggal dunia. Akibatnya, penghormatan terhadap kehendak pasien belum memperoleh pengakuan normatif yang memadai.

Ketiadaan pengaturan tersebut melahirkan berbagai persoalan yuridis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam praktik, ahli waris dapat membutuhkan rekam medis untuk penyelesaian sengketa, klaim asuransi, atau kepentingan hukum lainnya. Di sisi lain, rumah sakit dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rekam medis, sementara pasien mungkin telah memiliki kehendak tertentu mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh mengakses informasi kesehatannya setelah meninggal. Hukum positif Indonesia belum memberikan jawaban yang jelas mengenai kedudukan kehendak tersebut, batas kewenangan ahli waris, maupun prosedur pemberian akses terhadap data kesehatan setelah kematian pasien. Akibatnya, perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis justru berpotensi berbenturan dengan penghormatan terhadap kehendak pasien, kepentingan keluarga, serta kebutuhan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

Permasalahan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administrasi kesehatan, melainkan menyentuh prinsip fundamental otonomi pasien (*patient autonomy*). Dalam hukum kesehatan dan bioetika, otonomi pasien merupakan hak setiap individu untuk menentukan keputusan mengenai tubuh, tindakan medis, serta informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penghormatan terhadap otonomi pasien meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperkuat pengambilan keputusan yang berpusat pada pasien (Seh et al., 2020). Namun, hampir seluruh kajian tersebut masih membatasi otonomi pasien pada fase ketika

individu masih hidup. Padahal, perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan baru, yaitu apakah hak untuk menentukan penggunaan informasi kesehatan seharusnya juga tetap dihormati setelah pasien meninggal dunia. Kekosongan konseptual inilah yang belum banyak memperoleh perhatian dalam kajian hukum kesehatan di Indonesia.

Dalam perkembangan hukum internasional persoalan tersebut mulai dijelaskan melalui konsep post-mortem privacy, yaitu gagasan bahwa kematian tidak serta-merta menghapus seluruh kepentingan hukum terhadap informasi pribadi seseorang (Harbinja et al., 2026). Perdebatan mengenai digital legacy menunjukkan bahwa individu pada umumnya memiliki preferensi mengenai pengelolaan aset digital setelah kematian, tetapi belum tersedia mekanisme hukum maupun teknologi yang mampu menjamin pelaksanaan kehendak tersebut. Rekam Medis Elektronik merupakan bagian dari identitas digital yang memuat informasi paling sensitif mengenai seseorang, sehingga persoalan akses terhadap data tersebut setelah kematian tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan medis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia, hak menentukan nasib informasi pribadi, serta perlindungan privasi dalam ruang digital (Holt et al., 2026).

Apabila dibandingkan dengan Malaysia terlihat bahwa perlindungan terhadap data pribadi orang yang telah meninggal masih memiliki keterbatasan. Melalui Personal Data Protection Act 2010 beserta perkembangan pengaturannya, perlindungan data pribadi pada prinsipnya hanya diberikan kepada individu yang masih hidup sehingga data orang yang telah meninggal tidak termasuk sebagai data subject (Ghani et al., 2020). Di sisi lain, Malaysia tetap mengenal penghormatan terhadap kehendak seseorang melalui Human Tissues Act 1974, yang mengatur penggunaan jaringan tubuh berdasarkan persetujuan semasa hidup atau kewenangan pihak tertentu setelah kematian (Ismail, 1996). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep post-mortem privacy belum diakui secara eksplisit, terdapat upaya untuk mengakomodasi kehendak individu dalam konteks tertentu. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia juga memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara kehendak pasien, hak keluarga, dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan (Khoo & Ballesté, 2024).

Penelitian mengenai Rekam Medis Elektronik di Indonesia umumnya berfokus pada perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data. Di sisi lain, penelitian mengenai blockchain lebih banyak mengkaji aspek keamanan dan integritas data, sedangkan kajian mengenai patient autonomy berkembang dalam konteks pengambilan keputusan medis ketika pasien masih hidup (Komalasari & Mustafa, 2024). Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian yang menghubungkan prinsip otonomi pasien, konsep post-mortem privacy, dan tata kelola akses Rekam Medis Elektronik setelah kematian dalam satu kerangka hukum yang utuh (Mandey, 2025a). Kekosongan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar bagaimana menjaga kerahasiaan data, melainkan bagaimana hukum memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan nasib data kesehatannya setelah meninggal dunia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa pengaturan hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi otonomi pasien terhadap Rekam Medis Elektronik pasca-kematian. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum yang tidak hanya mempertahankan prinsip kerahasiaan rekam medis, tetapi juga menyediakan mekanisme yang memungkinkan kehendak pasien dinyatakan, diverifikasi, dan dilaksanakan secara akuntabel. Dalam konteks tersebut, teknologi blockchain diposisikan bukan sebagai tujuan penelitian, melainkan sebagai instrumen pendukung untuk mencatat digital consent, menyediakan immutable audit trail, serta memperkuat kepastian hukum dalam pemberian akses terhadap Rekam Medis Elektronik (Santoso et al., 2024). Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan pengaturan hukum mengenai akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian, mengkaji relevansi konsep post-mortem privacy dalam memperkuat otonomi pasien, serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan hukum berbasis blockchain sebagai upaya mewujudkan perlindungan privasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam sistem kesehatan digital Indonesia.

## **II. RESEARCH METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta regulasi terkait di Malaysia. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep patient autonomy, post-mortem privacy, dan teknologi blockchain, serta pendekatan perbandingan (comparative approach) guna membandingkan pengaturan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian di Indonesia dengan Malaysia sebagai bahan rekonstruksi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi sekitar 30 literatur yang terdiri atas jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku, dan dokumen ilmiah yang diterbitkan terutama dalam kurun waktu 2019–2026 serta dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan membandingkan norma hukum serta konsep yang berkembang, kemudian menyusun argumentasi hukum secara preskriptif untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian melalui pendekatan post-mortem privacy dan teknologi blockchain.

## **III. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION**

### **3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Akses Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkembangan transformasi digital di sektor kesehatan telah mendorong perubahan sistem pencatatan rekam medis konvensional menuju Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dalam ekosistem layanan kesehatan nasional. Digitalisasi tersebut meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan melalui kemudahan akses informasi medis, kontinuitas pelayanan, serta efisiensi administrasi. Namun, di sisi lain, karakteristik RME sebagai kumpulan data kesehatan yang bersifat sensitif juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi apabila tidak disertai dengan sistem perlindungan hukum yang memadai (Azmi et al., 2024). Oleh karena itu, hukum Indonesia tidak hanya memandang RME sebagai dokumen administratif pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai informasi yang mengandung hak privasi pasien dan wajib dilindungi. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pasien meninggal dunia karena muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis dengan kepentingan keluarga, ahli waris, maupun pihak lain yang secara hukum memerlukan akses terhadap informasi kesehatan pasien.

Perlindungan terhadap Rekam Medis Elektronik di Indonesia secara normatif dibangun melalui tiga instrumen hukum utama, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Ketiga regulasi tersebut membentuk suatu rezim hukum yang saling melengkapi dalam mengatur penyelenggaraan RME, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, serta tata cara pemanfaatan data medis dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap Rekam Medis Elektronik tidak hanya berada dalam ranah hukum kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari rezim perlindungan data pribadi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa data kesehatan dipandang sebagai hak individual yang harus dijaga dari setiap bentuk pemrosesan maupun pengungkapan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah (Lestari et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan yuridis terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan. Melalui pengaturan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan diwajibkan membuat, menyimpan, mengelola, serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pengakuan terhadap RME dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan rekam medis konvensional, sehingga setiap informasi yang terkandung di dalamnya memperoleh perlindungan hukum yang sama (Benseghir et al., 2025). Selain berfungsi sebagai alat dokumentasi medis, RME juga memiliki nilai pembuktian dalam penyelesaian sengketa hukum serta menjadi dasar pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu,

keberadaan RME harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang menjamin integritas, keamanan, dan kerahasiaan data kesehatan pasien(Mandey, 2025b).

Perlindungan terhadap informasi kesehatan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengategorikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (specific personal data(Mandalika et al., 2025). Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa data kesehatan memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik maupun mental seseorang. Konsekuensinya, setiap kegiatan pemrosesan data kesehatan wajib dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data atau dasar hukum lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta harus memenuhi prinsip legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, keamanan, dan akuntabilitas. Dalam konteks Rekam Medis Elektronik, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memperluas perlindungan yang semula hanya berorientasi pada kerahasiaan medis menjadi perlindungan terhadap hak privasi pasien sebagai pemilik data pribadi(Setiyanta & Dewi, 2025).

Sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mengatur secara lebih rinci tata kelola Rekam Medis Elektronik, mulai dari proses pembuatan, penyimpanan, pertukaran data, hingga pembukaan informasi rekam medis(Saputra, 2024). Regulasi ini menegaskan bahwa rekam medis merupakan dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya karena memuat informasi mengenai identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, serta terapi pasien. Oleh sebab itu, fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menerapkan sistem keamanan yang mampu menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data selama proses penyelenggaraan RME. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan kerahasiaan rekam medis sebagai prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan digital sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi pasien(Mandalika et al., 2025).

Meskipun prinsip kerahasiaan menjadi dasar utama pengelolaan Rekam Medis Elektronik, hukum Indonesia tetap memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh akses terhadap informasi medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indra et al., 2024). Pada dasarnya, pasien sebagai subjek data memiliki hak utama untuk memperoleh informasi mengenai rekam medisnya. Selain pasien, akses terhadap Rekam Medis Elektronik juga dapat diberikan kepada keluarga terdekat atau ahli waris dalam kondisi tertentu, penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, peneliti yang memenuhi persyaratan etik dan perlindungan kerahasiaan data, serta pihak lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hak akses tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh tujuan penggunaan, asas proporsionalitas, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien(Mubarak et al., 2025).

Pengaturan mengenai akses Rekam Medis Elektronik setelah pasien meninggal dunia diatur secara terbatas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Pasal 32 menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan isi rekam medis tetap berlaku meskipun pasien telah meninggal dunia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan kerahasiaan antara tenaga kesehatan dan pasien tidak berakhir karena kematian, melainkan tetap mengikat sebagai bagian dari kewajiban profesional dan perlindungan terhadap martabat pasien. Di sisi lain, Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 membuka kemungkinan dilakukannya pengungkapan isi rekam medis dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan penegakan hukum, audit kesehatan, penelitian, pendidikan, maupun kepentingan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan tetap menjadi aturan umum, sedangkan pembukaan akses merupakan pengecualian yang harus memenuhi syarat hukum secara ketat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kekosongan hukum dalam pengaturan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian tidak hanya berkaitan dengan belum adanya pengakuan terhadap konsep post-mortem privacy, tetapi juga belum tersedianya mekanisme hukum yang mengakomodasi otonomi pasien untuk menentukan pihak yang berhak mengakses data kesehatannya setelah meninggal dunia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek kerahasiaan rekam medis, perlindungan data pribadi, atau keamanan sistem informasi kesehatan, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menempatkan kehendak pasien sebagai dasar utama pemberian akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian. Rekonstruksi tersebut diusulkan melalui mekanisme Digital Health Advance Directive berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan persetujuan pasien dicatat secara permanen (immutable), diverifikasi melalui jejak audit (audit trail), serta dilaksanakan secara otomatis berdasarkan otorisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pemanfaatan blockchain dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen pendukung untuk mewujudkan kepastian hukum, penghormatan terhadap otonomi pasien, dan perlindungan post-mortem privacy dalam tata kelola Rekam Medis Elektronik.

### **3.2. Kedudukan Otonomi Pasien Dalam Menentukan Akses Terhadap Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian Ditinjau Dari Konsep Post-Mortem Privacy**

Prinsip patient autonomy merupakan salah satu prinsip fundamental dalam bioetika dan hukum kesehatan yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang berhak menentukan nasibnya sendiri (self-determination)(Lewis & Holm, 2022). Menurut Beauchamp dan Childress, penghormatan terhadap otonomi mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan diri seseorang dibuat secara bebas, sadar, dan tanpa paksaan (Childress & Beauchamp, 2022). Dalam pelayanan kesehatan, prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme informed consent sebagai bentuk pengakuan atas hak pasien untuk menerima, menolak, maupun memilih tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Namun, perkembangan hukum kesehatan modern menunjukkan bahwa ruang lingkup otonomi pasien tidak berhenti pada persetujuan tindakan medis semata. Otonomi juga mencakup hak pasien untuk mengendalikan informasi kesehatannya, termasuk menentukan siapa yang dapat mengetahui,

menggunakan, atau memperoleh akses terhadap Rekam Medis Elektronik yang memuat data pribadi bersifat sensitif(Wilkinson et al., 2025).

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Rekam Medis Elektronik tidak hanya memiliki fungsi administratif atau klinis, tetapi juga merupakan perwujudan hak privasi pasien. Informasi mengenai riwayat penyakit, diagnosis, terapi, kondisi psikologis, hingga data genetik merupakan bagian dari identitas personal yang perlindungannya melekat pada martabat manusia(Kovács, 2024). Oleh karena itu, pengendalian atas informasi kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi pasien. Artikel *Impact of Nurse-Patient Relationship on Quality of Care and Patient Autonomy in Decision-Making* menegaskan bahwa hubungan pelayanan kesehatan seharusnya tidak didominasi oleh tenaga kesehatan, melainkan memberikan ruang bagi pasien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks tersebut, penghormatan terhadap otonomi tidak hanya berarti memberikan pilihan atas tindakan medis, tetapi juga mengakui hak pasien untuk menentukan bagaimana informasi kesehatannya akan digunakan dan kepada siapa informasi tersebut dapat diungkapkan(Molina-Mula & Gallo-Estrada, 2020).

Meskipun demikian, muncul persoalan ketika pasien telah meninggal dunia. Secara klasik, kematian dipandang mengakhiri status seseorang sebagai subjek hukum sehingga berbagai hak yang bersifat pribadi dianggap turut berakhir. Pandangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hak pasien untuk menentukan penggunaan informasi kesehatannya juga otomatis berakhir ketika ia meninggal dunia? Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut tidak lagi sesederhana pendekatan hukum konvensional. Data digital, termasuk Rekam Medis Elektronik, tetap tersimpan, dapat diakses, disalin, bahkan dimanfaatkan jauh setelah pemiliknya meninggal dunia. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai apakah kepentingan seseorang terhadap data pribadinya masih patut memperoleh perlindungan hukum setelah kematian.

Perdebatan tersebut melahirkan konsep *post-mortem privacy*, yaitu gagasan bahwa informasi pribadi seseorang tetap memiliki nilai perlindungan meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perlindungan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk menjaga kerahasiaan data, tetapi juga untuk menghormati martabat, reputasi, kehendak semasa hidup, serta kepentingan hukum yang masih melekat pada individu setelah kematiannya(Harbinja et al., 2024). Dalam konteks masyarakat digital, konsep ini berkembang melalui pembahasan mengenai *digital legacy*, yaitu pengelolaan akun digital, surat elektronik, media sosial, penyimpanan awan (*cloud storage*), hingga data kesehatan yang tetap eksis setelah kematian pemiliknya. Penelitian mengenai *post-mortem data* menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi apakah data tersebut masih ada, melainkan siapa yang memiliki legitimasi untuk menentukan akses, penggunaan, maupun pengelolaannya.

Konsep *post-mortem privacy* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *patient autonomy*. Apabila selama hidup pasien diakui memiliki hak untuk menentukan tindakan medis, memilih tenaga kesehatan, memberikan atau menolak persetujuan, serta mengendalikan informasi kesehatannya, maka secara filosofis tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengabaikan kehendak pasien mengenai



penggunaan Rekam Medis Elektronik setelah ia meninggal dunia(Arthanti, 2025). Dengan demikian, persoalan hukum yang muncul bukan lagi sekadar apakah Rekam Medis Elektronik tetap harus dirahasiakan setelah pasien meninggal, melainkan siapa yang berhak menentukan pihak yang dapat mengaksesnya. Pergeseran perspektif ini penting karena membedakan antara hak untuk mengakses Rekam Medis Elektronik (right of access) dan hak untuk menentukan siapa yang memperoleh akses (right to determine access). Hak yang kedua merupakan manifestasi langsung dari otonomi pasien yang hingga kini belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam sistem hukum Indonesia(Bak & Willems, 2022).

Apabila dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan Rekam Medis Elektronik. Bahkan Pasal 32 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa kerahasiaan Rekam Medis tetap wajib dijaga meskipun pasien telah meninggal dunia. Namun demikian, pengaturan tersebut belum mengakomodasi mekanisme yang memungkinkan pasien menetapkan sejak semasa hidup siapa yang berhak maupun tidak berhak mengakses Rekam Medis Elektronik setelah kematian. Ketentuan mengenai pembukaan Rekam Medis lebih berorientasi pada persetujuan pasien, keluarga terdekat, atau ahli waris dalam kondisi tertentu, tanpa mengatur secara eksplisit kedudukan kehendak pasien apabila bertentangan dengan keinginan pihak lain. Dengan demikian, hukum Indonesia masih menitikberatkan pada aspek confidentiality, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi autonomy.

Pendekatan tersebut dapat dibandingkan dengan Malaysia Meskipun Personal Data Protection Act 2010 beserta perkembangannya tidak mengakui individu yang telah meninggal sebagai data subject, sistem hukumnya tetap mengenal penghormatan terhadap persetujuan yang diberikan semasa hidup dalam konteks tertentu, misalnya melalui Human Tissues Act 1974 mengenai penggunaan jaringan tubuh setelah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Malaysia belum mengakui post-mortem privacy sebagai hak privasi yang berdiri sendiri, terdapat pengakuan bahwa kehendak seseorang sebelum meninggal tetap memiliki relevansi hukum pada situasi tertentu. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa perlindungan terhadap kepentingan individu pasca-kematian tidak selalu diwujudkan melalui perluasan definisi hak privasi, tetapi dapat dibangun melalui mekanisme hukum yang menghormati preferensi atau persetujuan yang dinyatakan semasa hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan otonomi pasien dalam menentukan akses terhadap Rekam Medis Elektronik pasca-kematian masih belum memperoleh perlindungan yang optimal dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan yang ada telah menjamin kerahasiaan data kesehatan setelah pasien meninggal dunia, tetapi belum memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan secara eksplisit nasib data kesehatannya setelah kematian. Akibatnya, muncul kekosongan norma mengenai hubungan antara kehendak pasien, kewenangan keluarga atau ahli waris,

serta hak akses pihak lain terhadap Rekam Medis Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum yang tidak hanya mempertahankan prinsip kerahasiaan, tetapi juga mengakui otonomi pasien melalui pendekatan post-mortem privacy. Rekonstruksi tersebut menjadi landasan konseptual bagi pemanfaatan teknologi blockchain sebagai mekanisme yang mampu merekam, memverifikasi, dan melaksanakan kehendak pasien secara aman, transparan, serta akuntabel setelah pasien meninggal dunia.

### **3.3. A Model Model Rekonstruksi Pengaturan Hukum Mengenai Akses Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian Yang Mampu Mengakomodasi Otonomi Pasien Melalui Pendekatan Post-Mortem Privacy Dan Teknologi Blockchain**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan hukum positif dan konsep patient autonomy pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan Rekam Medis Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis(Amin et al., 2021). Namun demikian, perlindungan tersebut masih berorientasi pada aspek confidentiality dan belum mengakomodasi dimensi otonomi pasien dalam menentukan nasib data kesehatannya setelah meninggal dunia.

Pengaturan yang berlaku belum memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan pasien menyatakan secara eksplisit pihak yang berhak maupun tidak berhak mengakses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai kedudukan kehendak pasien apabila bertentangan dengan kepentingan keluarga, ahli waris, maupun pihak lain yang memperoleh akses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep post-mortem privacy, yaitu penghormatan terhadap kepentingan dan preferensi individu atas informasi pribadinya setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum yang tidak hanya mempertahankan prinsip kerahasiaan Rekam Medis Elektronik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip otonomi pasien sebagai dasar penentuan akses pasca-kematian. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak pasien, kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik melalui dukungan teknologi yang memadai.

Rekonstruksi pengaturan hukum mengenai akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian tidak dapat dilakukan hanya dengan menambahkan ketentuan mengenai pihak yang berhak memperoleh akses terhadap data kesehatan pasien. Rekonstruksi tersebut harus dibangun di atas prinsip-prinsip hukum yang mampu menjawab kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan(Sudra, 2021). Dengan demikian, perubahan norma tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kekosongan hukum, tetapi juga

memastikan bahwa sistem yang dibangun tetap memberikan perlindungan terhadap hak pasien, kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan data kesehatan. Berdasarkan analisis sebelumnya, setidaknya terdapat lima prinsip fundamental yang harus menjadi dasar dalam merumuskan model pengaturan baru, yaitu penghormatan terhadap otonomi pasien, post-mortem privacy, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keamanan data.

Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap otonomi pasien (patient autonomy). Prinsip ini menghendaki agar pasien tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan menentukan nasib informasi kesehatannya, termasuk setelah meninggal dunia. Selama ini pengaturan hukum lebih menitikberatkan pada kewenangan keluarga atau ahli waris dalam memberikan persetujuan pembukaan Rekam Medis Elektronik, sementara kehendak pasien yang mungkin telah dinyatakan semasa hidup belum memperoleh pengakuan secara eksplisit (Narendra et al., 2020). Akibatnya, keputusan mengenai akses terhadap Rekam Medis Elektronik berpotensi bergeser dari kehendak pasien kepada pihak lain. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus memberikan ruang bagi pasien untuk menetapkan secara langsung pihak yang berhak maupun tidak berhak mengakses Rekam Medis Elektroniknya sejak masih hidup sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap prinsip self-determination.

Prinsip kedua adalah post-mortem privacy. Berbeda dengan konsep kerahasiaan yang hanya berfokus pada larangan membuka informasi tanpa kewenangan, post-mortem privacy menempatkan perlindungan terhadap kepentingan pasien setelah meninggal dunia sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan preferensi individu. Dalam konteks Rekam Medis Elektronik, perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan data kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa kehendak pasien mengenai penggunaan informasi medisnya tetap dihormati setelah kematian (Hurruzia & Adisasmito, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak cukup hanya mempertahankan kewajiban menjaga kerahasiaan Rekam Medis Elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mengakui bahwa pasien memiliki kepentingan hukum untuk menentukan akses terhadap data kesehatannya setelah meninggal dunia.

Prinsip ketiga adalah kepastian hukum. Pengaturan yang tidak memberikan mekanisme yang jelas mengenai hubungan antara kehendak pasien, hak keluarga, kewenangan ahli waris, dan kepentingan pihak lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pelayanan kesehatan. Rumah sakit sering kali dihadapkan pada dilema antara memenuhi permintaan keluarga atau mempertahankan kerahasiaan Rekam Medis Elektronik karena tidak terdapat norma yang secara tegas mengatur prioritas kepentingan tersebut (Darmawan, 2023). Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum harus menghasilkan mekanisme yang mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai pihak yang berhak memperoleh akses berdasarkan preferensi pasien yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepastian hukum tersebut tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengambil keputusan.

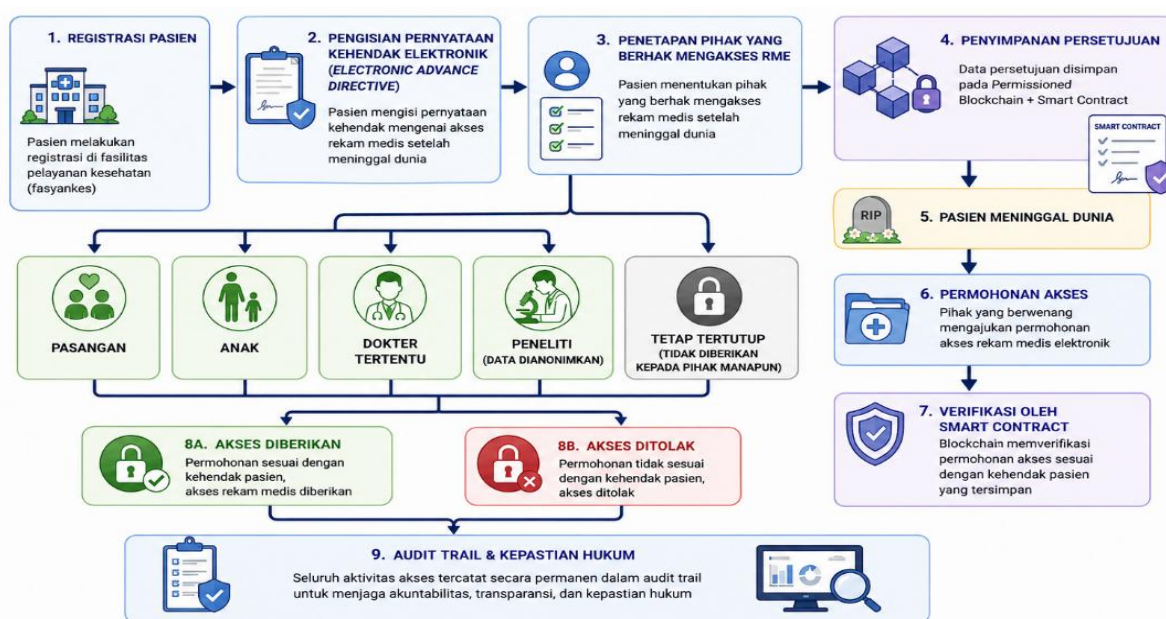
Prinsip keempat adalah akuntabilitas. Setiap tindakan pembukaan, penggunaan, maupun penolakan akses terhadap Rekam Medis Elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui mekanisme pencatatan yang transparan dan dapat diaudit. Akuntabilitas menjadi penting mengingat data kesehatan merupakan kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Tanpa mekanisme pencatatan yang memadai, penyalahgunaan akses maupun perubahan data akan sulit dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, sistem pengelolaan Rekam Medis Elektronik harus mampu mendokumentasikan seluruh aktivitas akses sehingga setiap tindakan memiliki jejak digital (audit trail) yang dapat diverifikasi.

Prinsip terakhir adalah keamanan data (data security). Perlindungan terhadap Rekam Medis Elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan sistem teknologi dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan keaslian data. Risiko kebocoran, manipulasi, maupun perubahan data kesehatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus berjalan seiring dengan penguatan mekanisme keamanan teknologi (Dady, 2026). Dalam konteks tersebut, teknologi blockchain bukan diposisikan sebagai tujuan rekonstruksi hukum, melainkan sebagai instrumen yang mampu mendukung implementasi kelima prinsip tersebut. Karakteristik blockchain berupa immutable ledger, mekanisme kriptografi, permissioned access, smart contract, dan audit trail memungkinkan kehendak pasien yang telah dinyatakan semasa hidup terdokumentasi secara autentik, tidak mudah dimanipulasi, serta dapat diverifikasi setiap kali terjadi permintaan akses terhadap Rekam Medis Elektronik pasca-kematian. Dengan demikian, penggunaan blockchain memperoleh legitimasi bukan karena perkembangan teknologi semata, melainkan karena kemampuannya memenuhi kebutuhan hukum yang belum dapat dijawab oleh sistem pengaturan yang berlaku saat ini (Syukurillah et al., 2024).

Berdasarkan kelemahan pengaturan hukum yang berlaku saat ini, penulis menawarkan rekonstruksi pengaturan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian yang berorientasi pada penghormatan terhadap otonomi pasien. Menurut penulis, mekanisme tersebut harus dimulai sejak pasien melakukan registrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyatakan kehendaknya mengenai pengelolaan Rekam Medis Elektronik setelah meninggal dunia. Kehendak tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak elektronik (electronic advance directive) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rekam Medis Elektronik. Melalui mekanisme ini, pasien dapat menentukan secara sadar pihak yang diberikan hak akses maupun pihak yang dikecualikan dari akses terhadap data kesehatannya (Tampubolon et al., 2022). Dengan demikian, pemberian akses setelah pasien meninggal tidak lagi hanya didasarkan pada persetujuan keluarga atau ahli waris, tetapi terlebih dahulu mengacu pada kehendak pasien yang telah dinyatakan secara sah semasa hidup.

Menurut penulis model tersebut mampu menggeser orientasi pengaturan dari sekadar perlindungan kerahasiaan (confidentiality) menuju penghormatan terhadap otonomi pasien (patient autonomy) sebagai pemilik utama informasi kesehatan. Agar mekanisme tersebut memiliki kepastian

hukum dan dapat diimplementasikan secara efektif, pernyataan kehendak elektronik pasien perlu disimpan melalui sistem berbasis permissioned blockchain. Pemanfaatan blockchain tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem Rekam Medis Elektronik yang telah ada, melainkan sebagai lapisan tata kelola (governance layer) yang mencatat persetujuan pasien secara permanen, terenkripsi, tidak dapat dimanipulasi (immutable), serta dapat diverifikasi melalui audit trail (Sonia et al., 2026). Dengan demikian, setiap permintaan akses terhadap Rekam Medis Elektronik pasca-kematian dapat diverifikasi berdasarkan kehendak pasien yang terdokumentasi, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak pasien, kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kesehatan..



**Gambar 1. Model Konseptual Rekonstruksi Pengaturan Akses Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian**

Pemanfaatan teknologi blockchain dalam model rekonstruksi pengaturan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian dipilih bukan semata-mata karena merupakan inovasi teknologi, melainkan karena karakteristiknya mampu menjawab kebutuhan hukum yang belum dapat dipenuhi oleh sistem pengelolaan Rekam Medis Elektronik saat ini. Menurut penulis, persoalan utama bukan terletak pada penyimpanan data kesehatan, melainkan pada mekanisme pembuktian dan pelaksanaan kehendak pasien setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, teknologi blockchain diposisikan sebagai instrumen pendukung yang memastikan bahwa pernyataan kehendak elektronik (electronic advance directive) yang dibuat oleh pasien tersimpan secara autentik, tidak dapat diubah secara sepihak (immutable ledger), serta tetap dapat diverifikasi ketika muncul permohonan akses terhadap Rekam Medis Elektronik. Karakteristik tersebut memberikan jaminan bahwa preferensi pasien yang telah dinyatakan semasa hidup tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, sehingga penghormatan

terhadap otonomi pasien tidak berhenti pada saat kematian, tetapi tetap terlindungi melalui mekanisme teknologi yang memiliki kekuatan pembuktian dan integritas data yang tinggi.

Selain menjaga integritas data blockchain juga mendukung terwujudnya prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik. Melalui mekanisme smart contract, sistem dapat secara otomatis memverifikasi setiap permintaan akses berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan pasien tanpa memerlukan interpretasi yang berbeda-beda dari pihak pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (Ramadahni, 2024). Di sisi lain, fitur audit trail memungkinkan setiap aktivitas akses, perubahan izin, maupun penolakan permohonan terdokumentasi secara permanen dan dapat diaudit apabila terjadi sengketa hukum. Penggunaan mekanisme kriptografi (cryptography) dan sistem permissioned blockchain juga memberikan perlindungan terhadap risiko manipulasi maupun akses tanpa kewenangan, sehingga hanya pihak yang memperoleh otorisasi berdasarkan kehendak pasien atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakses informasi tersebut (Setiawan et al., 2020). Dengan demikian, menurut penulis, blockchain tidak menggantikan fungsi hukum sebagai dasar pemberian hak akses, melainkan memperkuat implementasi norma hukum melalui sistem yang lebih transparan, aman, akuntabel, dan mampu menjamin terlaksananya kehendak pasien secara konsisten.

**Tabel 1. Blockchain dalam konstruksi hukum**

| <b>Fitur Blockchain</b> | <b>Fungsi Teknis</b>                 | <b>Nilai Hukum yang didukung</b>        |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Immutable ledger        | Data tidak dapat diubah              | Kepastian Hukum dan Integritas bukti    |
| Smart contract          | Eksekusi otomatis sesuai persyaratan | Penghormatan terhadap otonomi pasien    |
| Audit trail             | Seluruh aktivitas tercatat           | Akuntabilitas & Pembuktian              |
| Cryptography            | Enkripsi dan kontrol akses           | Kerahasiaan & Perlindungan data pribadi |
| Permissioned Blockchain | Akses terbatas bagi pihak berwenang  | Perlindungan hak pasien & Keamanan data |

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekosongan pengaturan hukum mengenai otonomi pasien dalam menentukan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian, menurut penulis rekonstruksi hukum perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya terbatas pada perubahan norma dalam satu peraturan perundang-undangan. Rekonstruksi tersebut harus mencakup pembaruan substansi hukum, penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, serta integrasi dengan teknologi yang mampu menjamin pelaksanaan kehendak pasien secara efektif. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu direkonstruksi agar perlindungan terhadap hak pasien, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik dapat diwujudkan secara optimal, yakni sebagai berikut:

**a) Rekonstruksi Norma dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 telah mengatur mengenai kerahasiaan dan pembukaan Rekam Medis Elektronik, namun belum memberikan pengaturan yang secara

eksplisit mengakui hak pasien untuk menentukan pihak yang berhak maupun tidak berhak mengakses Rekam Medis Elektronik setelah meninggal dunia. Menurut penulis, diperlukan penambahan norma yang mengakomodasi **pernyataan kehendak elektronik (*electronic advance directive*)** sebagai dasar hukum utama dalam pemberian akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian.

**b) Penguatan Prinsip Otonomi Pasien dalam Undang-Undang Kesehatan**

Selain perubahan pada tingkat peraturan pelaksana, rekonstruksi juga perlu didukung oleh penguatan norma pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan tersebut perlu menegaskan bahwa penghormatan terhadap otonomi pasien tidak berhenti pada pemberian persetujuan tindakan medis, tetapi juga mencakup hak pasien untuk menentukan penggunaan informasi kesehatannya setelah meninggal dunia sebagai bagian dari perlindungan hak atas data pribadi dan martabat manusia.

**c) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Menurut penulis, perubahan regulasi tidak akan efektif tanpa didukung oleh mekanisme operasional yang jelas. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyusun standar operasional prosedur mengenai pencatatan, perubahan, pencabutan, dan pelaksanaan pernyataan kehendak elektronik pasien. Standar operasional tersebut juga harus mengatur tata cara verifikasi identitas pihak yang mengajukan akses, prosedur pemberian maupun penolakan akses, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa antara kehendak pasien dan kepentingan keluarga atau ahli waris.

**d) Pengembangan Sistem *Consent Management* Berbasis Blockchain**

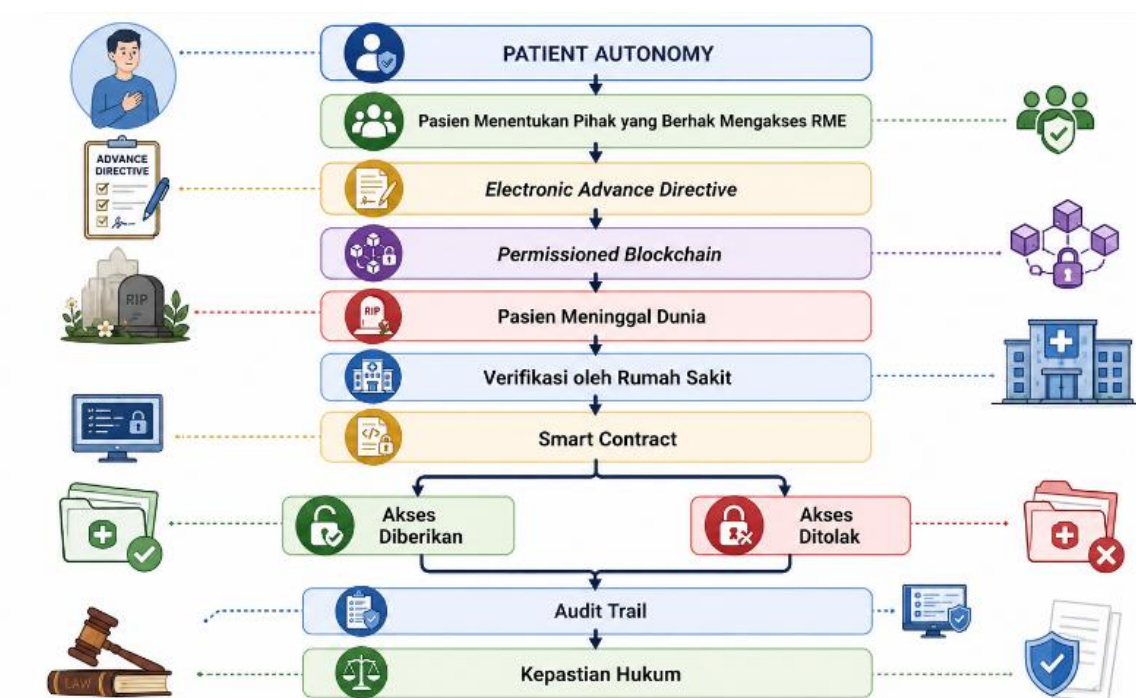
Sebagai bentuk implementasi dari rekonstruksi hukum yang diusulkan, sistem Rekam Medis Elektronik perlu dikembangkan dengan menambahkan fitur consent management berbasis permissioned blockchain. Fitur tersebut berfungsi untuk merekam persetujuan pasien secara permanen, memverifikasi setiap permintaan akses berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan, serta mencatat seluruh aktivitas akses melalui mekanisme audit trail. Menurut penulis, penggunaan blockchain tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem Rekam Medis Elektronik yang telah ada, tetapi menjadi instrumen yang memperkuat pelaksanaan norma hukum melalui sistem yang aman, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi pengaturan hukum mengenai akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian tidak cukup diwujudkan melalui penambahan norma baru, melainkan memerlukan harmonisasi antara regulasi, tata kelola kelembagaan, dan dukungan teknologi. Menurut penulis, sinergi ketiga aspek tersebut akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, menghormati otonomi pasien, memberikan kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, serta memperkuat perlindungan terhadap post-mortem privacy di Indonesia.

Sebagai bentuk rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang berlaku saat ini, penulis menawarkan suatu model konseptual pengelolaan akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian yang berlandaskan pada prinsip patient autonomy, konsep post-mortem privacy, dan didukung oleh teknologi blockchain sebagai instrumen implementasinya. Model ini dibangun berdasarkan temuan bahwa permasalahan utama dalam pengaturan Rekam Medis Elektronik di Indonesia bukan terletak pada kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien, melainkan belum adanya mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada pasien untuk menentukan pihak yang berhak mengakses informasi kesehatannya setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, titik awal rekonstruksi bukanlah penerapan teknologi blockchain, melainkan pengakuan terhadap hak pasien untuk menentukan nasib Rekam Medis Elektroniknya sejak masih hidup. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui pernyataan kehendak elektronik (electronic advance directive) yang menjadi bagian integral dari sistem Rekam Medis Elektronik dan memiliki kedudukan sebagai dasar utama dalam pemberian maupun penolakan akses terhadap data kesehatan pasien pasca-kematian.

Menurut penulis, blockchain tidak seharusnya diposisikan sebagai tujuan dari rekonstruksi hukum, melainkan sebagai instrumen yang menjamin pelaksanaan norma hukum secara efektif. Setelah pasien menyampaikan electronic advance directive, preferensi tersebut disimpan dalam sistem permissioned blockchain sehingga memiliki karakteristik autentik, terenkripsi, tidak dapat diubah secara sepihak (immutable ledger), serta dapat diverifikasi setiap kali terdapat permohonan akses terhadap Rekam Medis Elektronik. Selanjutnya, ketika pasien meninggal dunia, fasilitas pelayanan kesehatan melakukan verifikasi terhadap permintaan akses dengan mengacu pada preferensi yang telah direkam dalam blockchain. Proses tersebut kemudian dijalankan melalui mekanisme smart contract yang secara otomatis menyesuaikan pemberian atau penolakan akses berdasarkan kehendak pasien maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aktivitas akses selanjutnya terdokumentasi melalui audit trail sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa hukum. Dengan demikian, model konseptual yang diusulkan tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap post-mortem privacy, tetapi juga menghadirkan sistem pengelolaan Rekam Medis Elektronik yang lebih transparan, akuntabel, aman, serta memberikan kepastian hukum bagi pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pihak lain yang berkepentingan.





**Gambar 2. Model Konseptual Rekonstruksi Pengaturan Akses Rekam Medis Elektronik Pasca-Kematian Berbasis Otonomi Pasien melalui Teknologi Blockchain**

#### IV. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai akses Rekam Medis Elektronik (RME) pasca-kematian dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi kesehatan pasien melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada prinsip confidentiality dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip patient autonomy, khususnya mengenai kewenangan pasien untuk menentukan pihak yang dapat atau tidak dapat mengakses Rekam Medis Elektronik setelah meninggal dunia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait kedudukan kehendak pasien, batas kewenangan keluarga atau ahli waris, serta mekanisme pemberian akses terhadap data kesehatan pasca-kematian. Dalam perspektif post-mortem privacy, kematian tidak serta-merta menghilangkan kepentingan hukum seseorang terhadap informasi pribadinya, sehingga kehendak pasien yang telah dinyatakan semasa hidup tetap memiliki relevansi untuk dihormati sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak atas privasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum akses Rekam Medis Elektronik pasca-kematian yang tidak hanya mempertahankan kewajiban menjaga kerahasiaan data,

tetapi juga memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan nasib informasi kesehatannya setelah meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap mekanisme electronic advance directive sebagai dasar utama dalam menentukan pemberian atau penolakan akses terhadap RME, penguatan prinsip otonomi pasien dalam regulasi kesehatan, penyusunan standar operasional prosedur di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengembangan sistem consent management berbasis permissioned blockchain. Teknologi blockchain dalam model ini tidak diposisikan sebagai pengganti norma hukum, melainkan sebagai instrumen pendukung yang mampu menjamin autentikasi kehendak pasien, menyediakan immutable ledger, mekanisme audit trail, serta pengendalian akses yang aman dan akuntabel. Dengan demikian, integrasi antara regulasi, tata kelola kelembagaan, dan teknologi blockchain dapat membentuk sistem pengelolaan Rekam Medis Elektronik pasca-kematian yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak pasien, kepastian hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan, serta perlindungan post-mortem privacy dalam ekosistem kesehatan digital Indonesia.

## BIBLIOGRAPHY

- Amin, M., Setyonugroho, W., & Hidayah, N. (2021). *Implementation Of Electronic Medical Records: A Qualitative Study | Jatisi*. Retrieved From <https://Jurnal.Mdp.Ac.Id/Index.Php/Jatisi/Article/View/557>
- Arthanti, W. B. (2025). Implementasi Otonomi Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia: Tinjauan Etik Dan Hukum: The Principle Of Autonomy In Medical Practice In Indonesia: A Review Of Ethics And Laws. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 174–187. <https://doi.org/10.30649/Jhek.V5i2.249>
- Azmi, F., Rahayu, B. Z., & Babo, D. H. P. (2024). Legalitas Hak Pasien Dalam Menentukan Perawatan Untuk Berobat. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 2597–2604. <https://doi.org/10.31004/Jkt.V5i2.26936>
- Bak, M. A. R., & Willems, D. L. (2022). Contextual Exceptionalism After Death: An Information Ethics Approach To Post-Mortem Privacy In Health Data Research. *Science And Engineering Ethics*, 28(4), 32. <https://doi.org/10.1007/S11948-022-00387-0>
- Benseghir, M., Zerara, A., Bentría, M., Bendriss, H., & Muhtar, M. H. (2025). Legal Aspects Of Patient Data Governance In Digital Health: A Comparative Analytical Study Of Uae And Indonesian Legislation. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 10(2), 773–808. <https://doi.org/10.15294/Jils.V10i2.10025>
- Childress, J. F., & Beauchamp, T. L. (2022). Common Morality Principles In Biomedical Ethics: Responses To Critics. *Cambridge Quarterly Of Healthcare Ethics*, 31(2), 164–176. <https://doi.org/10.1017/S0963180121000566>
- Dady, R. D. (2026). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Pada Rekam Medis Elektronik: Analisis Hukum Kesehatan Indonesia. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 7(2), 316–327. <https://doi.org/10.59784/Glosains.V7i2.680>
- Darmawan, A. (2023). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (Jmiki)*, 11(1). <https://doi.org/10.33560/Jmiki.V11i1.500>
- Ghani, F. A., Shabri, S. M., Rasli, M. A. M., Razali, N. A., & Shuffri, E. H. A. (2020). *An Overview Of The Personal Data Protection Act 2010 (Pdpa): Problems And Solutions*. 12(4).
- Harbinja, E., Mcvey, M., & Edwards, L. (2024). Post-Mortem Privacy And Digital Legacy—A Qualitative Enquiry. *Scripted: A Journal Of Law, Technology And Society*, 21, 4. Retrieved From <https://Access.Heinonline.Com/Hol/Page?Handle=Hein.Journals/Scripted21&Id=4&Div=&Collection=>
- Harbinja, E., Morse, T., & Edwards, L. (2026). Digital Remains And Post-Mortem Privacy In The Uk: What Do Users Want? *International Review Of Law, Computers & Technology*, 40(1), 4–27. <https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2506164>
- Holt, J., Smeddinck, J. D., Nicholson, J., Vlachokyriakos, V., & Durrant, A. C. (2026). Post-Mortem Information Management: Exploring Contextual Factors In Appropriate Personal Data Access After Death. *Human–Computer Interaction*, 41(1), 26–61. <https://doi.org/10.1080/07370024.2023.2300792>
- Hurruzia, M. I., & Adisasmito, W. B. B. (2025). *Kesiapan Rumah Sakit Dalam Menerapkan Rekam Medis Elektronik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis*. 7(2).
- Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien Vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik. *Soepra*, 10(1), 97–117. <https://doi.org/10.24167/Sjkh.V10i1.11542>

- Ismail, S. B. S. (1996). Human Tissues Act, 1974: The Present And The Future. *Journal Of Malaysian And Comparative Law*, 23, 57–78. Retrieved From <https://ejournal.um.edu.my/index.php/jmcl/article/view/16111>
- Khoo, L. S., & Ballesté, C. (2024). A 25-Year Scoping Review Of The Organ Donation System In Malaysia: Past, Present, And Future. *Clinical Transplantation And Research*, 38(3), 163–187. <https://doi.org/10.4285/ctr.24.0020>
- Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Electronic Health Records In Indonesia: A Law And Policy Analysis. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 2(1). Retrieved From <https://jurnal.uic.ac.id/mk/article/view/310>
- Kovács, S. D. (2024). Patient Autonomy In The Era Of The Sustainability Crisis. *Medicine, Health Care And Philosophy*, 27(3), 399–405. <https://doi.org/10.1007/s11019-024-10214-x>
- Lestari, A. Y., Misran, M., Raharjo, T., Annas, M., Riskanita, D., & Prabandari, A. P. (2024). Improving Healthcare Patient Data Security: An Integrated Framework Model For Electronic Health Records From A Legal Perspective. *Law Reform*, 20(2), 329–352. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.56986>
- Lewis, J., & Holm, S. (2022). Patient Autonomy, Clinical Decision Making, And The Phenomenological Reduction. *Medicine, Health Care And Philosophy*, 25(4), 615–627. <https://doi.org/10.1007/s11019-022-10102-2>
- Mandalika, M. S., Banu, R. A. F., Irzaqie, R. A., & Muaja, V. D. (2025). Digitalisasi Rekam Medis Dalam Pusaran Hukum Analisis Pertanggungjawaban Malpraktik Medis Dan Perlindungan Data Pasien. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-Issn : 3031-8882*, 2(2), 1362–1369. <https://doi.org/10.62379/veegj712>
- Mandey, A. W. (2025a). Legal Analysis Of Patient Privacy Violation In Electronic Medical Records And Its Implications For Health Data Protection In Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(02), 589–594. Retrieved From <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/jms/article/view/6399>
- Mandey, A. W. (2025b). Legal Analysis Of Patient Privacy Violation In Electronic Medical Records And Its Implications For Health Data Protection In Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(02), 589–594. Retrieved From <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/jms/article/view/6399>
- Molina-Mula, J., & Gallo-Estrada, J. (2020). Impact Of Nurse-Patient Relationship On Quality Of Care And Patient Autonomy In Decision-Making. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 17(3), 835. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030835>
- Mubarak, H., Wiradirja, I. R., & Pranadita, N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tanggungjawab Rumah Sakit Pada Pengelolaan Privasi Dan Keamanan Rekam Medis Elektronik Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 69–76. Retrieved From <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/188>
- Mukharham, M. F., Nurita, D. P., & Paramarta, V. (2024). Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit. *Journal Of Social And Economics Research*, 6(1), 966–973. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.471>
- Narendra, I., Dewi, H. I. R., & Ismiyati. (2020). Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis Di Rumah Sakit Xy Sleman. *Jurnal Amanah Kesehatan*, 2(2), 27–34. <https://doi.org/10.55866/jak.v2i2.76>
- Ramadahni, K. (2024). The Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Manajemen Kesehatan Elektronik. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(2), 116–119. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i2.1097>
- Santoso, A. P. A., Soraes, D., Gegen, G., & Astuti, O. A. S. (2024). Ethics And Law Of Using Blockchain Technology For Electronic Health Records In Indonesia. *Proceeding Of*

- International Conference On Science, Health, And Technology*, 97–104. <https://doi.org/10.47701/Icohetech.V5i1.4134>
- Saputra, T. E. (2024). Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien: *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 57–75. <https://doi.org/10.34304/Jf.V13i2.276>
- Seh, A. H., Zarour, M., Alenezi, M., Sarkar, A. K., Agrawal, A., Kumar, R., & Ahmad Khan, R. (2020). Healthcare Data Breaches: Insights And Implications. *Healthcare*, 8(2), 133. <https://doi.org/10.3390/Healthcare8020133>
- Setiawan, E. P., Bhawiyuga, A., & Siregar, R. A. (2020). Pengembangan Sistem Rekam Medis Rumah Sakit Dengan Multi User Rest Server Berbasis Permissioned Blockchain Menggunakan Framework Hyperledger. *Jurnal Pengembangan Teknologi Dan Ilmu Komputer*, 4(1), 1–10. Retrieved From <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/6851>
- Setiyanta, P. T., & Dewi, M. P. (2025). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Keamanan Data Pribadi Pada Rekam Medis Di Indonesia. *J-Lee - Journal Of Law, English, And Economics*, 7(2), 36–45. Retrieved From <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/j-lee/article/view/2116>
- Sonia, D., Putra, D. H., & Nurmalasari, M. (2026). Blockchain Untuk Keamanan Data Kesehatan Dalam Rekam Medis Elektronik. *J-Remi : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 7(3), 209–218. <https://doi.org/10.25047/J-Remi.V7i3.6830>
- Sudra, R. I. (2021). Standardisasi Resume Medis Dalam Pelaksanaan Pmk 21/ 2020 Terkait Pertukaran Data Dalam Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (Jipiki)*, 6(1), 67–72. <https://doi.org/10.52943/Jipiki.V6i1.495>
- Syukurillah, A. S., Lutviana, & Purwono, P. (2024). Penggunaan Blockchain Dalam Rekam Medis Elektronik: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, 1(1), 33–55. Retrieved From <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa/article/view/1626>
- Tampubolon, J. O. Y., Bhawiyuga, A., & Siregar, R. A. (2022). Implementasi Blockchain Berbasis Bigchaindb Untuk Menjamin Keamanan Data Dalam Sistem Pencatatan Rekam Medis. *Jurnal Pengembangan Teknologi Dan Ilmu Komputer*, 6(3), 1471–1480. Retrieved From <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/10840>
- Tioorentap, D. R. A. (2020). Evaluasi Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review. *Indonesian Of Health Information Management Journal (Inohim)*, 8(2), 69–79. <https://doi.org/10.47007/Inohim.V8i2.218>
- Wilkinson, D., Levy, N., & Allen, J. (2025). Empowering Patient Autonomy: The Role Of Large Language Models (Llms) In Scaffolding Informed Consent In Medical Practice. *Bioethics*, 40(2). Retrieved From <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid%3a14495228-8f47-42e9-B699-F76c32b2c61>